



[首頁](#) > [傳染病與防疫專題](#) > [傳染病介紹](#) >

[第四類法定傳染病](#) > [流感併發重症](#) > [Q & A](#) >

[季節性流感疫苗](#) > [流感疫苗重點訊息](#) > [疫苗有效性與安全性](#)

疫苗有效性與安全性



全部收合

Q：什麼是疫苗保護力？怎麼評估？

疫苗保護力是指接種疫苗的人群與沒有接種疫苗的人群相比，減少多少罹病、重症或死亡的風險，是疫苗效力（vaccine efficacy）和疫苗效果（vaccine effectiveness）的統稱。疫苗效力可經由嚴謹的臨床試驗得知，然而因為每個臨床試驗的研究方法、執行地點與評估指標均不相同，所以不建議直接比較不同疫苗的臨床試驗結果，並以此評斷疫苗的優劣。而疫苗效果則是經由疫苗接種後研究資料得知。

最後更新日期 2026/8/7

Q：我今年接種了流感疫苗，還會感染流感嗎？

是的，即使接種過當季流感疫苗仍可能感染流感，這可能是由於以下原因：

1. 可能在接種疫苗前不久或在疫苗產生完整保護力前（約於接種疫苗後兩週內）即感染流感病毒。
2. 可能感染了未包含於當季流感疫苗內的流感病毒。每年有許多不同的流感病毒在流行，流感疫苗內僅包括根據監測結果顯示最可能之流行流感病毒。

3. 即使接種了流感疫苗，因疫苗提供的保護力會隨接種者的年齡和健康狀況而有所差異，有些人仍可能感染疫苗內所包括的流感病毒。一般來說，流感疫苗保護力在健康的年輕成人和較大的孩童間最佳，年長者和患有某些慢性疾病的人在接種疫苗後保護力稍差。

最後更新日期 2026/8/7

Q：如果我接種後還是感染了流感，流感疫苗對我有幫助嗎？ ^

有些人接種流感疫苗後仍可能感染流感。然而研究已顯示，接種流感疫苗可減少感染者的病情嚴重程度，降低重症與死亡的機率，因此還是建議接種流感疫苗。

最後更新日期 2026/8/14

Q：為何每年都要接種流感疫苗？ ^

由於流感病毒極易產生變異，幾乎每年流行的病毒株都會稍有不同，疫苗對不同抗原型之病毒保護效果會明顯降低，即使病毒未發生變異，疫苗成分相同，接種4-6個月後保護效果即可能下降，保護力一般不超過1年，因此建議每年均須接種1次，是全球一致性的作法。

最後更新日期 2026/8/14

Q：因應秋冬流感疫情，何時接種流感疫苗才來得及產生保護力？ ^

台灣歷年來流感疫情多自11月下旬開始升溫，於年底至翌年年初達到高峰，一般持續至農曆春節，於2、3月後趨於平緩，且接種疫苗後需一段時間產生保護力，故建議高風險及高傳播族群，應於10月流感疫苗開打後，儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力。

最後更新日期 2026/8/14

Q：接種流感疫苗後多久可以產生保護力？



完成流感疫苗接種（未滿9歲首次接種幼兒為接種第2劑），至少約2週後產生保護力。

最後更新日期 2026/8/14

Q：接種流感疫苗的保護效果如何？



根據國外文獻，流感疫苗之保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30-80%。對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有41%，入住加護病房的流感重症保護力則可達82%。6個月至未滿18歲兒童青少年族群接種流感疫苗之保護力與成人相仿。此外，疫苗保護效果亦需視當年疫苗株與實際流行的病毒株型別是否相符，一般保護力會隨病毒型別差異加大而降低。

最後更新日期 2026/8/14

Q：疫苗中使用的病毒株與流行的流感病毒「完全吻合（match）」是什麼意思？



指在某個流感季節中，用於製造流感疫苗的病毒抗原與在人群中流行的病毒抗原相似，因此接種疫苗後產生的抗體能夠提供最好的保護力。

最後更新日期 2026/8/14

Q：為什麼有時疫苗病毒株會與流行的流感病毒不吻合（mismatch）？



流感病毒不斷變化（稱為「抗原漂移」），有時在一個流感季內即可能發生明顯變化。由於製造流感疫苗需要幾個月的時間，專家必須在流感季開始前先選定要包含在當季疫苗中的病毒株，以確保疫苗能及時

生產和供應。雖然世界衛生組織（WHO）已經參考全球監測結果選出最可能流行的病毒株，但由於以上因素，疫苗所包含的病毒株和流行株之間可能出現不完全吻合的情況。

某些病毒株在雞胚蛋流感疫苗生產過程中，也可能累積抗原變異造成不吻合，特別是A型流感（H3N2）病毒最為明顯。

最後更新日期 2026/8/14

Q：如果流行的流感病毒與疫苗病毒株不吻合怎麼辦？



依國際文獻指出，當疫苗株吻合時保護力約為40-60%，疫苗株不吻合時平均估計保護力約為30-50%。因此，即使流感疫苗株與流行型別不吻合，接種流感疫苗仍能提供一定程度的保護力，為維護自身及家人的健康，仍建議民眾每年均接種疫苗。

最後更新日期 2026/8/14

Q：本季的疫苗能完全吻合將要流行的病毒嗎？



流感疫苗是根據研究和監測結果，針對即將到來的季節中最可能出現的流感病毒進行製備，由於流感病毒不斷變化，無法完全確定流感疫苗是否會與當季流行的流感病毒相符。

最後更新日期 2026/8/14

Q：流感疫苗安全嗎？會有什麼副作用？



1. 疫苗核准使用前，除了確認有效性之外，臨床試驗的各階段也包括完整的安全性評估。所有參與疫苗臨床試驗的受試者，均需記錄接種疫苗後是否出現局部或全身性反應（local or systemic reactogenicity），並和接種安慰劑或其他對照疫苗者比較，以確認這些不良反應的發生率是否高於預期。而由於臨床試驗僅有數萬名受試者，不一定能監測到罕見的疫苗不良事件（rare

adverse events，發生率低於1/10,000)，因此在疫苗取得上市許可後，仍須持續進行上市後安全監測。

2. 今年政府採購的各廠牌疫苗皆符合我國衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用/進口，安全無虞。
3. 疫苗與其他任何藥品一樣有可能造成副作用，包括接種後可能有注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1-2天內自然恢復。嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），發生機率非常低，若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。其他曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、以對稱性神經麻痺為表現的Guillain-Barré症候群等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。除了1976年豬流感疫苗、2009年H1N1新型流感疫苗與部分季節性流感疫苗經流行病學研究證實與Guillain-Barré症候群可能相關外，少有確切統計數據證明其他不良事件與接種流感疫苗有關。

最後更新日期 2026/8/14

Q：接種後若有副作用，該怎麼處理？



民眾若接種後產生副作用，建議立即至接種院所或其他醫療院所就醫。接種院所或學校於執行接種工作時/後，若發現有接種後屬嚴重疫苗不良事件之個案發生時，也請立即至疾管署建置之「疫苗不良事件通報系統」（網址：<https://vaers.cdc.gov.tw/>）進行線上通報。

最後更新日期 2026/8/14

Q：今年政府採購的流感疫苗品質是否有保障？



今年政府採購的各廠牌疫苗皆符合我國衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用/進口，同時每批疫苗均經食品藥物管理署檢驗合格，在品質上有保障。

最後更新日期 2026/8/14

Q：流感疫苗開始施打後，政府如何監測流感疫苗安全性？



於「疫苗不良事件通報系統」通報之資料，會交由食藥署/藥害救濟基金會之「全國藥物不良反應通報中心」進行疫苗安全訊號偵測及釐清，並定期公佈評估結果（網址：

<https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571>）。如分析後發現在疫苗安全性上有過去所不知或不清楚的重大情況，則須進一步釐清或是以流行病學研究方法進行評估，並考量是否須採行相關風險管理措施（如仿單加註），以確保疫苗接種之風險效益平衡。

最後更新日期 2026/8/14

Q：流感疫苗能否為COVID-19提供保護力？



不能，流感疫苗僅對流感病毒感染有保護力，無法預防COVID-19感染。

最後更新日期 2026/8/14

Q：民眾是否可以依靠群體免疫力來預防感染流感？



流感是藉由飛沫或接觸傳染，當接種率提升使群體免疫達到一定程度時，可能部分阻斷或減緩疾病的傳播；惟群體免疫是需要時間累積，接種率達到一定程度才會產生之效益，且主要是減緩疾病傳播，並無法降低個人感染風險，故針對流感高風險族群者，仍建議自身接種疫苗。

最後更新日期 2026/8/14